

보험금사정서



비밀
손해사정

損害査定 바른결

바른결 손해사정

우 07805

서울시 강서구 공항대로 242, 열린M타워II차 1014호

TEL 02-6958-6866 FAX 02-6008-4695

담당자 : 김태윤 010-7400-4716
2026. 04. 09.

문서번호 : 제26-087호
수 신 : KB손해보험
참 조 : 보험금 지급 담당자
제 목 : 손해 사정서 제출

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 2025년 10월 16일 발생한 보험사고 당사자인 “ ”에 대한 손해사정을 완료하여 보험업감독규정 제9-18조 제1항의 규정에 의하여 보험금사정서를 작성하여 별첨과 같이 보험금사정서 등을 제출하오니 보험업감독규정 제9-21조 2항의 규정에 따라 지체없이 처리하여 주시기 바랍니다.
3. 본 사정서를 접수한 보험회사는 보험업감독규정 제9-21조의 제2항 제1호 또는 제2호에 해당되어 정정보완이 필요한 경우에는 동조 제3항의 규정에 따라 사정서 접수일로부터 반드시 10일 이내에 구체적인 사유와 근거를 명시하여, 당사의 책임 손해사정사 또는 보험금 청구권자에게 서면으로 요청하여 주시기 바랍니다.
4. 의뢰인에게 보험약관에 의거 보험회사와 보험금 지급 등에 관하여 분쟁이 있는 경우 관리 감독기관에 설치된 보험분쟁조정위원회의 조정을 받을 수 있음을 알렸습니다.

※ 별 첨 : 보험금사정서 1부

바른결 손해사정



바른결
손해사정

바른결손해사정
CLAIM ADJUSTMENT

서울특별시 강서구 공항대로 242, 1014호

I. 사정 요약

1. 사정 근거

가. KB손해보험 KB 3.5.5 외 슬기로운건강보험Plus(무배당)(23.09)(24149) 약관

나. 보험계약법

2. 사정 금액

가. 특별약관

뇌질병진단비(뇌혈관질환(뇌졸중제외)

금 10,000,000원

진단비III

보험금 합계

금 10,000,000원

3. 보험금사정 의견

위 보험금 사정금액은 보험업법 제188조에 의하여 위 보험의 약관, 관련 법규, 해당 주치의가 발행한 진단서, 의무기록, 의료자문 결과 등을 근거로 본 손해사정사가 사정한 의견으로 피보험자 “윤광석”님의 보험금으로 타당하다고 판단됩니다.

2026. 04. 09.

책임사정사 김 태 윤



II. 위임 및 보험계약사항

1. 보험금사정업무의 위임

가. 수임내용

본건 보험사고로 인한 피보험자 “ ” 본인으로부터 KB손해보험의 보험금 사정에 대하여 보험업법 제188조의 규정에 따라 보험금사정업무를 의뢰 받음.

나. 피보험자의 인적사항

- 1) 성 명 : (이하 “피보험자”라 함)
- 2) 생년월일 :
- 3) 주 소 :
- 4) 연 락 처 :

다. 위임자

위 사고당사자임

라. 손해사정 업무를 수행하는 손해사정사

- 1) 신체손해사정사 : 김태윤 (금융감독원 등록번호 BD00001058호)
- 2) 소속 : 바른결손해사정
- 3) 연락처 : 010 - 7400 - 4716

마. 상세 수임내용

1) 피해자 질병사고 인하여 발생한 뇌질병
진단비(뇌혈관질환(뇌졸중제외)진단비)III 특약의 손해사정

2. 보험계약사항

보험종목	증권번호	보험기간	계약자	피보험자	수익자
KB 3.5.5 오! 슬기로운간편 건강보험 Plus (무배당) (23.09) (24149)		2023. 10. 16. ~ 2043. 10. 16.			

Ⅲ. 보험사고 발생의 조사·확인한 사실

1. 진단경위

피보험자는 두통 및 어지럼증으로 서울시 소재
에 내원하여 2025. 10. 10. 시행한 뇌 MRI 검사상 양측 뇌실 주변
및 대뇌 피질하 백질의 소혈관질환 소견이 확인되었다 진단받음.

2. 치료관계내역

가. 주요 상병명

기타 명시된 뇌혈관질환 (I678)

다. 현 상태

피보험자는 현재까지 지속적인 치료를 받고 있으나, 뇌혈관질환으로 인하여 향후 지속적인 경과 관찰을 요하는 상태임.

IV. 관계법규 및 약관의 적용·판단

1. 보험금 지급책임 발생

가. 보험금의 지급사유

1) 통합 뇌질병진단비III 특별약관

회사는 피보험자가 이 특별약관의 보험기간 중에 통합뇌질병으로 진단확정된 경우에는 질병 구분에 따라 각각 최초 1회의 진단에 한하여 아래의 금액을 통합뇌질병진단비로 보험수익자에게 지급합니다.

나. 특별 약관의 적정성 여부

1) 뇌혈관질환(뇌졸중제외) 정의 및 진단확정

뇌혈관질환 (뇌졸중제외)	출혈 또는 경색증으로 명시되지 않은 뇌졸중	I64
	기타 뇌혈관 질환	I67
	달리 분류된 질환에서의 뇌혈관장애	I68
	뇌혈관질환의 후유증	I69

① 이 특별약관에 있어서 "통합뇌질병"이라 함은 "뇌전증", "일과성뇌허혈발작", "뇌혈관질환(뇌경색·뇌출혈)", "뇌혈관질환(협착증)" 및 "뇌혈관질환(뇌졸중제외)"를 총칭합니다.

② 이 특별약관에 있어서 "뇌혈관질환(뇌졸중제외)"이라 함은 제8차 한국표준질병사인분류에 있어서 뇌혈관질환(뇌졸중제외)으로 분류되는 질병 (【별표10】 (통합뇌질병 분류표) 참조)을 말합니다.

② "뇌혈관질환(뇌경색·뇌출혈)", "뇌혈관질환(협착증)" 및 "뇌혈관질환(뇌졸중제외)"의 진단확정은 의료법 제3조(의료기관)에서 정한 국내의 병원이나 의원 또는 국외의 의료관련법에서 정한 의료기관의 의사(치과의사 제외) 면허를 가진 자에 의하여 내려져야 합니다. 이 진단은 병력, 신경학적 검진과 함께 뇌 전산화단층촬영(brain CT scan), 자기공명영상(MRI), 뇌혈관조영술, 양전자방출단층술(PET), 단일광자방출 전산화 단층술(SPECT), 뇌척수액 검사 등을 기초로 하여야 합니다. 또한 회사가 "뇌혈관질환(뇌경색·뇌출혈)", "뇌혈관질환(협착증)" 및 "뇌혈관질환(뇌졸중제외)"의 조사나 확인을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 검사결과, 진료기록부의 사본제출을 요청할 수 있습니다.

피보험자의 진단명인 기타 명시된 뇌혈관질환(I678)은 통합뇌질병 분류표 기타 뇌혈관질환 (I67)에 해당하고,

또한, 2026년 04월 03일 시행한 신경외과 의료자문 결과에 따르면
에 내원하여 뇌 MRI 검사 결과 양측 뇌실 주변 및 대
뇌 피질하 백질의 소혈관질환 소견이 확인 되었으며 양측 대뇌백질 변성(허혈성 병변)의 정도는 기타 명시된 뇌혈관질환(I67.8) 진단 부여에 있어 중요한 판단요소 중 하나이며 경도의 백질 변화라 하더라도 환자의 연령, 고혈압 등 기저 위험인자, 임상 증상과의 연관성을 종합적으로 고려하여 뇌소혈관질환의 초기 단계로 판단되는 경우에는 I67.8 진단을 적용할 수 있다라는 자문의 소견이 확인 됨. (백질변성의 정도는 I67.8 진단 여부를 결정하는 절대적인 기준은 아니며, 영상 소견의 정도와 함께 임상적 맥락을 종합적으로 평가하여 판단하는 것이 의학적으로 타당함)

다. 보험금 지급책임

[별첨 제01호] 진단서와 같이 피보험자는 임상증상인 두통 및 어지럼증으로 에 내원하여 뇌 MRI 검사 상 양측 뇌실 주변 및 대
뇌 피질하 백질의 소혈관질환 소견이 확인 되었으며 “기타 명시된 뇌혈관질환(I67.8)” 최종진단 받은 사실이 확인되어 보험 약관에서 정한 통합 뇌질병 진단비(뇌혈관질환(뇌졸중제외)진단비III)에 해당하는 보험회사의 보험금 지급책임을 발생함.

2. 면책사유 검토

가. 해당보험 보통약관 [보험금을 지급하지 않는 사유]에서는 피보험자, 수익자, 계약자의 고의로 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하지 아니하거나 보험료의 납입을 면제하지 아니함과 동시에 이 계약을 해지할 수 있다고 명시하고 있으나,

나. 본 보험사고는 해당약관 [보험금을 지급하지 않는 사유]에 해당되는 사항이 없으므로 보험회사의 보험금지급책임은 당연히 존재한다 할 것임.

V. 보험금 사정

1. 보험금 사정내역

통합 뇌질병진단비(뇌혈관질환(뇌졸중제외)진단비)Ⅲ : 10,000,000원

2. 보험금 사정금액

위의 제반 검토내용을 토대로 볼 때 상기의 금액을 피보험자의 보험금으로 사정하는 것이 적절하다 하겠음.

—금 일천만원整 (₩10,000,000)—

3. 사정 결과 및 의견

본 손해사정은 보험약관 및 진단서, 의무기록, 의료자문결과지 등을 근거로 사정한 것으로 피보험자의 보험금으로 적정하다고 판단됨.

한편, 본 사고가 원인이 되어 보험금 사정 시점에 예기치 못한 추가보험금이 발생할 경우에 대하여는 보험금 사정을 유보함.

VI. 증빙자료

1. 진단서
2. 초진기록지
3. 경과기록지
4. 영상판독지
5. 검사결과지
6. 의료자문결과지
7. 보험증권 사본
8. 신분증 및 통장사본
9. 위임장 사본

책임사정사 김 태 윤



문서확인번호 00

본 증명서는 발급일로부터 90일까지 <http://kangnam.medcenter11.com>에서 원본 확인이 가능합니다.

표 의료법 시행규칙 [별지 제5호의2서식] <개정 2019.8.27>

진 단 서

등록번호		환자의 주민등록번호	
연 번 호			
환자의 성명			
환자의 주소	(전화번호)		
임상적 추정 최종진단 ☐ ☒	병 명 (주요병·부상) 기타 명시된 뇌혈관질환		질병분류기호 1678
발병 연월일	환자진술	진단 연월일	
치료 내용 및 향후 치료에 대한 소견	상기 환자는 두통, 어지럼증으로 내원하여 상병명으로 진단 받고 외래 통원치료 중입니다. 향후 일정 기간 이상의 경과 관찰 및 통원 치료가 필요할 것으로 예상됩니다. 마발견중이나 합병증 발생시 추가 진단이 발 급될 수 있습니다.		
입원·외원 연월일	입원일:	부터	외원일:
용 도	보험사 제출용		
비 고			

「의료법」 제17조 및 같은 법 시행규칙 제8조제1항에 따라 위와 같이 진단합니다.

의료기관 명칭 :

주소 :

2025년 10월 16일

☒ 의사 ☐ 치과의사 ☐ 한의사 연월번호 제 호

성 명 :

작성 방법

1. 환자의 인적사항은 진료한 의사, 치과의사 또는 한의사가 주민등록증, 기간 만료 전 여권, 운전면허증, 공무원증, 국립·공립대학 학생증, 군무
원증, 건강보험증, 외국면허증 등 국가공인 신분증(한자가 이상한지인 경우에는 주민등록증본·소본, 학생증 등으로 대체 가능합니다)과 대조
하여 확인하고 서명 또는 날인합니다.
2. "병명"란에는 "임상적 추정"과 "최종진단"을 적입하여 []에 √표시를 하고, 질병명은 한글로 적되 영어로 적을 경우에는 한글을 붙여
적으며, 질병분류기호도 함께 적습니다.

등록번호:

성명:

주민번호:

진료일: _____

나이/성별:

외래기록지

● [2025-09-30 10:57]

주호소 증상

두통, 어지럼증

통증평가(있을 경우 하단 버튼 눌러 평가)

Numeric Rating Scale : 중등도[6]

◆ 중등도 이상의 통증에 대한 중재 :

- 관찰 (observation)

◆ 통증의 양상 : 쑤심

◆ 통증의 위치 : 머리 전체

◆ 통증의 빈도 : 간헐적

◆ 통증의 기간 : 1분

Present illness

2025-04부터 갑자기 시작된 두통, 어지럼증으로 진료위해 내원함.

#무직

Past history

HTN(-) / DM(-) / Tbc(-) / Hepatitis(-) / Cancer(-)/ 골다공증/심근경색/DL/전립선 비대증

[self po]

포렌드플러스디정 1T D (골다사관련약) -> 2025.04.11 마지막 복용

애드칼정 2T D (칼슘,비타민 D)

로스톤정5mg 1T D (고지혈증 치료제)

몰시톤정4mg 1T D (협심증 치료제) -> 두통 시 타이레놀 복용 or 감량함.
일성이습틴서방정18 0.5T D (칼슘채절 길항제)

탐루신디서방정 0.4mg 1T D (전립선 비대약)

Family History

HTN(-) / DM(-) / Tbc(-) / Hepatitis(-) / Cancer(-)/ 뇌출혈/ 뇌경색

- 부: 뇌출혈

- 모: 뇌경색

Social history

Alcohol(-) / Smoking(+) / Exercise(+)

- 흡연: 하루에 2갑

- 권투: 하루에 2시간

Objective Data

MRI & MRA

Assessment/Impression

R/O SVD

Plan

2025-09-30 기록변경 불가능하다 설명드립니다. MRI & MRA

알려지 여부

없음

작성자 :

● [2025-09-30 11:03

] 외래기록지

기록내용

Subjective Data

Objective Data

■ 신경학적 검사(neurologic examination) ■

■ Mental status & High cognitive function

- ▶ Level of consciousness : alert
- ▶ Orientation :
 - * time : normal
 - * place : normal
 - * person : normal
- ▶ Language :
 - * comprehension : normal
 - * verbal : normal

■ Cranial

- ▶ Pupil light reflex : * Lt : normal * Rt : normal
- ▶ Pupil size : isocoria * Rt : 3 / * Lt : 3 / * EOM : full
- ▶ Facial motor : normal
- ▶ Facial sensory : normal
- ▶ Tongue deviation : No
- ▶ Gag reflex : normal

■ Motor (Power & Tone)

- ▶ Right upper : Grade V
- ▶ Left upper : Grade V
- ▶ Right lower : Grade V
- ▶ Left lower : Grade V
- ▶ Muscle tone : (normal)

■ Sensory

- ▶ Right touch : normal
- ▶ Pinprick : normal

■ Reflex

- ▶ Deep tendon reflex :
 - * Biceps - Right : 2+ Left : 2+
 - * Triceps - Right : 2+ Left : 2+
 - * Knee - Right : 2+ Left : 2+
 - * Ankle - Right : 2+ Left : 2+
- ▶ Pathologic reflex :
 - * Babinski - Right : No
 - * Babinski - Left : No
 - * Ankle Clonus - Right : No
 - * Ankle Clonus - Left : No
 - * Hoffman - Right : No
 - * Hoffman - Left : No

■ Cerebellar/ Vestibular function test

- ▶ Dysmetria : normal
- ▶ Romberg test : normal

■ Gait

- ▶ Gait : normal
- ▶ Tandem gait : normal

■ NIHSS : Total []

- 1a[] 1b[] 1c[] 2[] 3[] 4[]
- 5a[] 5b[] 6a[] 6b[] 7[] 8[]
- 9[] 10[] 11[]

Assessment/Impression

Plan

● [2025-10-16 14:53]

작성자

기록내용

Subjective Data

2025-04부터 갑자기 시작된 두통, 어지럼증으로 진료위해 내원함.

Objective Data

■ FINDING : - Pulse sequence: sagittal T1WI, axial T1 & T2 WI, FLAIR, SWI, coronal T2WI
- MRA: Intracranial and neck TOF MRA
- Contrast [-]

1. Brain & cranial vault

- Minimal chronic ischemic lesions in both cerebral white matter.
- 4mm pineal cyst.
- No definite mass, hemorrhage, hydrocephalus, atrophy

2. Vasculature (MRA)

- No evidence of occlusion, stenosis nor aneurysm in visible arteries

3. Others

- Maxillary sinusitis, left with fungal ball.

【판독의/확인】 :

【처방일/보고일】 20250930 / 20251014

Assessment/Impression

Small vessel disease

Plan

2025-10-16 medication x 30 진단서 작성 - 삼성화재, KB손보, 외래 진료 사실 증명서 작성

작성자 :

● [2025-10-30 10:46]

기록내용

Subjective Data

2025-04부터 갑자기 시작된 두통, 어지럼증으로 진료위해 내원함.

#무직

Objective Data

■ FINDING : - Pulse sequence: sagittal T1WI, axial T1 & T2 WI, FLAIR, SWI, coronal T2WI

- MRA: Intracranial and neck TOF MRA
- Contrast [-]

1. Brain & cranial vault

- Minimal chronic ischemic lesions in both cerebral white matter.
- 4mm pineal cyst.
- No definite mass, hemorrhage, hydrocephalus, atrophy

2. Vasculature (MRA)

- No evidence of occlusion, stenosis nor aneurysm in visible arteries

3. Others

- Maxillary sinusitis, left with fungal ball.

【판독의/확인】

【처방일/보고일】 20250930 / 20251014

Assessment/Impression

Small vessel disease

Plan

2025-10-16 medication x 30 진단서 작성 -

외래 진료 사실 증명서 작성

2025-10-30 medication x 60 CT 문의 - 경미해서 의미 없다고 설명드릴

작성자 :

이 하 여 백

등록번호
성명
주민번호

성별

검사결과보고서

두부(MRI)

검사명 MRI(Brain+3D Angio)(원외 영상전문의판독)
진료의사 진료과

검사 실시일시 20251010 11:17
보고일시 20251014 11:19
보고의사

판독일시 20251014 11:19
판독의사

■ FINDING : - Pulse sequence: sagittal T1WI, axial T1 & T2 WI, FLAIR, SWI, coronal T2WI
- MRA: Intracranial and neck TOF MRA
- Contrast [-]

1. Brain & cranial vault
 - Minimal chronic ischemic lesions in both cerebral white matter.
 - 4mm pineal cyst.
 - No definite mass, hemorrhage, hydrocephalus, atrophy
2. Vasculature (MRA)
 - No evidence of occlusion, stenosis nor aneurysm in visible arteries
3. Others
 - Maxillary sinusitis, left with fungal ball.

검사명
진료의사

진료과

검사 실시일시
보고일시
보고의사

판독일시
판독의사

(전문의 번호:)

환자명	생년월일	성별
-----	------	----

[질문 1] 일반적으로 기타 명시된 뇌혈관질환(I67.8) 정의 및 진단기준은 무엇인가요?

☒ 1. 정의

뇌혈관질환(I67)은 뇌혈관의 비정상적인 상태로 인해 발생하는 다양한 비염증성 질환을 포함합니다. 이 코드 하의 질환들은 대개 만성적이며, 급성 뇌혈관 사고(뇌졸중)와는 구분됩니다. 즉, 주로 만성 뇌혈관 질환을 지칭하는 경우가 많습니다.

☑ 2. 진단기준

진단 기준은 질환의 유형에 따라 다르지만, 공통적으로 사용되는 평가 방법들은 다음과 같습니다:

임상 증상: 만성적이고 진행성인 뇌기능 저하, 두통, 어지럼증, 경련 등.

영상학적 검사: MRI, CT, 뇌혈관조영술(angiography) 등을 통해 혈관의 구조적 이상을 확인합니다.

혈관 기능 평가: 도플러 초음파를 통해 혈류의 이상 여부를 평가할 수 있습니다.

병리학적 검사: 필요한 경우, 뇌조직의 생검을 통해 혈관 벽의 변화를 확인할 수 있습니다.

☒ 3. 진단 범위

167 뇌혈관질환 진단에는 파열되지 않은 뇌혈관의 박리증, 동맥류 및 동정맥류, 뇌혈관의 죽상경화증, 모야모야 병, 뇌혈관의 동맥염(arteritis), 뇌의 급성 또는 만성적인 허혈성 변화(백질 변성, 소혈관질환 등) 또는 달리 분류 되지 않는 뇌혈관 질환(뇌출혈, 뇌경색, 뇌혈관협착증 이외)의 진단에 적용 됩니다.

[질문 2] 신경외과 진료기록부 및 영상자료 상, 환자의 내원경위, 신경학적 검진결과, Brain MRI+MRA 검사결과 주요 소견은 무엇인지요? (병변부위 영상자료 첨부 부탁드립니다)

☒ 상기 환자는 두통 및 어지럼증을 주소로 2025년 9월 30일 내원하였고 뇌MRI 검사 결과 양측 뇌실 주변 및 대뇌 피질하 백질의 소혈관질환 소견 확인되었습니다.

[질문 3] Brain MRI+MRA 검사결과 양측 대뇌백질 변성(허혈성 병변)은 어느 정도인가요? (Grade 0-3)

☒ 제출된 MRI 소견에서 확인되는 백질 고신호는 양측 뇌실 주변과 대뇌 백질의 경도의 변화로, 임상적으로 Fazekas grading 기준 Grade 1 수준의 백질변성에 해당합니다.

[질문 4] 상기 양측 대뇌백질 변성(허혈성 병변) 정도에 따라 기타명시된뇌혈관질환 1678 진단을 달리 하는지요?
판단의 이유는 무엇인지요?

☑ 양측 대뇌백질 변성(허혈성 병변)의 정도는 기타 명시된 뇌혈관질환(167.8) 진단 부류에 있어 중요한 판단 요소 중 하나입니다. 경도의 백질 변화라 하더라도 환자의 연령, 고혈압 등 기저 위험인자, 임상 증상과의 연관성을 종합적으로 고려하여 뇌소혈관질환의 초기 단계로 판단되는 경우에는 167.8 진단을 적용할 수 있습니다.

☑ 따라서 백질변성의 정도는 167.8 진단 여부를 결정하는 절대적인 기준은 아니며, 영상 소견의 정도와 함께 임상적 맥락을 종합적으로 평가하여 판단하는 것이 의학적으로 타당합니다.

[질문 5] 신경학적 결손 또는 증상 유무에 따라 기타 명시된 뇌혈관질환(I67.8) 진단명 부여가 차이가 있는지요? 판단의 근거는 무엇인지요?

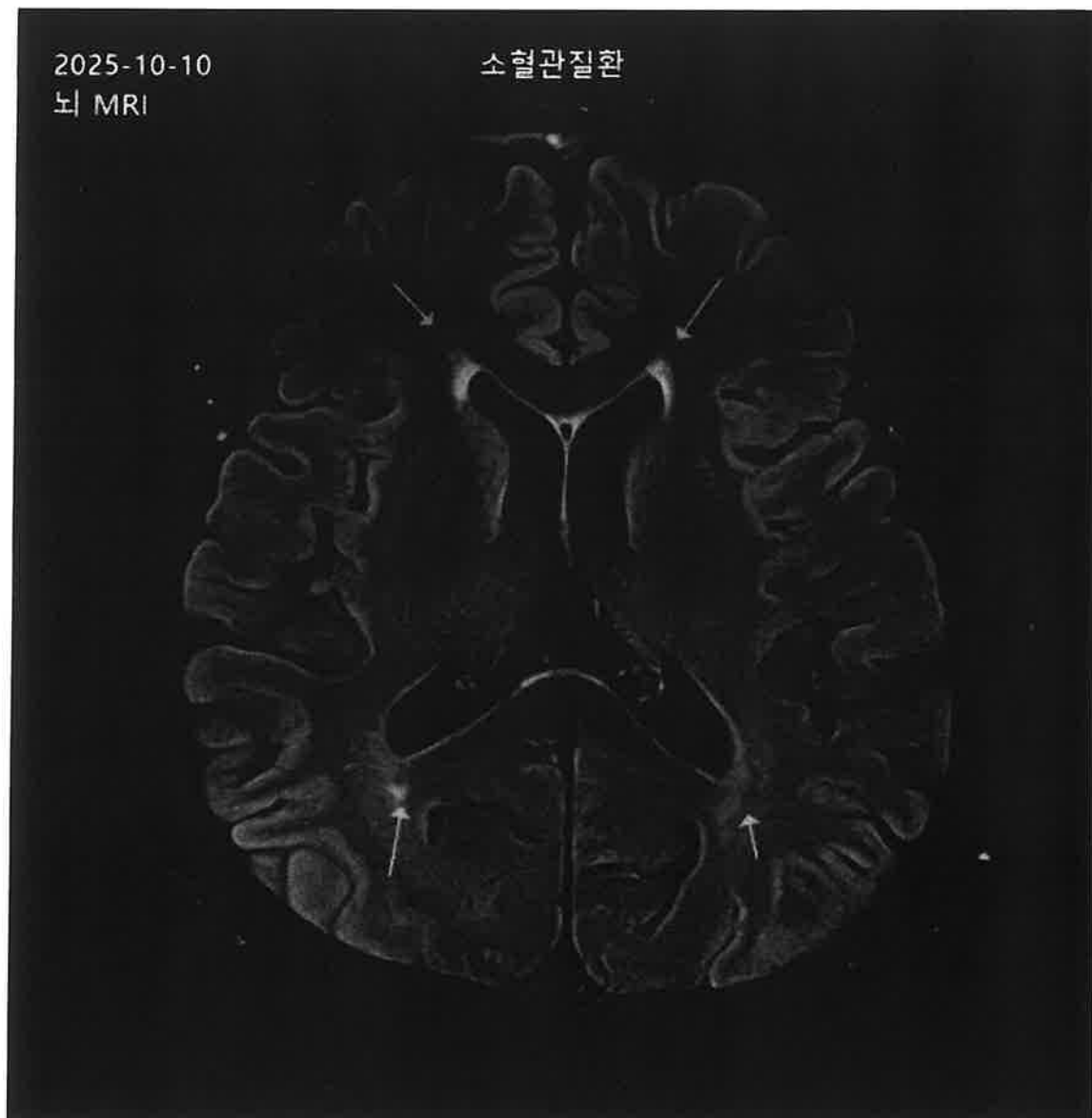
☑ 기타 명시된 뇌혈관질환(I67.8)의 진단은 반드시 신경학적 결손이 동반되어야만 부여되는 것은 아니며, 영상학적 이상 소견과 임상적 맥락을 종합적으로 고려하여 판단합니다.

☑ 일반적으로 뇌혈관질환은 무증상 상태에서도 영상검사를 통해 발견되는 경우가 많으며, 특히 소혈관질환 (small vessel disease)이나 백질변성은 신경학적 결손 없이도 확인될 수 있습니다. 이러한 경우에도 해당 소견이 단순 노화 변화의 범위를 넘어 뇌혈관 병변으로 판단되고, 환자의 임상 증상(두통, 어지럼증 등) 또는 향후 뇌혈관질환 위험과의 관련성이 고려되는 경우에는 I67.8 진단을 부여할 수 있습니다.

☑ 따라서 신경학적 결손의 유무는 진단의 참고 요소 중 하나일 뿐 필수 조건은 아니며, 영상학적 소견의 존재 및 임상적 의미를 종합적으로 평가하여 판단하는 것이 의학적으로 타당합니다.

[질문 6] 제8차 한국표준질병사인분류(KCD)에 질병코딩지침에 따른 최종진단명 및 질병분류코드는 무엇인지요?

☑ I678 기타 명시된 뇌혈관질환 입니다.



KB금융그룹

KB손해보험

보험증권(계약자용)



계약 내용

보험료

계약자 | 증권번호

계약형태

보험기간

납입형태

만기수익자

예상만기환급금

장래인 전용보험

전문특약

계약자주소

1회보험료

보장보험료

적립보험료

보험료할인

※ 보험증권은 계약체결의 단순 확인사항이며, 담보 및 가입 금액이나 보험금을 지급하지 아니하는 사유 등 계약내용 및 담보별 상세내용은 청약서 및 보험약관에 따라 결정됩니다.

※ 이 보험증권은 「보험업감독규정」 제4-35조의2·제7-45조, 「보험업감독업무시행세칙」 제5-11조 및 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제19조, 동법 시행령 제13조·제14조 및 동법 감독규정 제12조·제13조에 의거하여 "KB손해보험"의 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공되는 자료입니다.

피보험자

계약담보

년/월지급형담보

면책기간

피보험자

사망수익자

법정상속인

계약자와의 관계

사망외수익자

수익자지정약정

피보험자주소

보장명 및 보장내용

가입금액

납입기간

보험기간

1 일반상해사망(355간편가입)(경신형)

보험기간중 상해의 직접결과로써 사망시

1백만원

20년

9 일반상해80%이상후유장해(355간편가입)(경신형)

보험기간 중에 상해로 장애분류표(약관참조)에서 정한 80%이상 후유장해시 (최초1회에 한함)

1백만원

20년

98 통합 뇌질환진단비(뇌혈관질환(협착증)진단비)(355간편가입)(경신형)

보험기간 중에 "뇌혈관질환(협착증)"(약관참조)으로 진단 확정시(최초1회한)

※ 보험계약일로부터

90일미만 시 보험가입금액 10% 지급

90일이상 1년미만 시 보험가입금액의 50% 지급

1천만원

20년

100 통합 뇌질환진단비(뇌혈관질환(뇌졸중제외)진단비)(355간편가입)(경신형)

보험기간 중에 "뇌혈관질환(뇌졸중제외)"(약관참조)으로 진단 확정시(최초1회한)

※ 뇌혈관질환(뇌졸중제외) : 출혈 또는 경색증으로 명시되지 않은 뇌졸중, 기타 뇌혈관 질환, 달리 분류된 질환에서의 뇌혈관장애, 뇌혈관질환의 후유증

※ 보험계약일로부터

90일미만 시 보험가입금액 10% 지급

90일이상 1년미만 시 보험가입금액의 50% 지급

1천만원

20년

KB마크가 있는 경우에만 원본으로 인정됩니다.

KB마크

대표이사
사 장대표이사
사 장 구본욱고객센터
(상단 또는 우측)

1544-0114

홈페이지

www.kbinsure.co.kr
m.kbinsure.co.kr

영업담당자

수도GA3-프린티어1지점 | 한국보험금융(주)씨에스우리위드보험대리
점(미영숙) | ☎010-7685-2227

발급일시

2025-12-22
14:39:00

20236147840 [계약자용]

- 1/7 -

202512221439002903785110

KB 금융그룹

KB 손해보험

보장명 및 보장내용	가입금액	납입기간	보험기간
102 통합 뇌질환진단비(뇌혈관질환(뇌경색·뇌출혈)진단비)Ⅲ(355간편가입)(경신형) 보험기간 중에 "뇌혈관질환(뇌경색·뇌출혈)"(약관참조)으로 진단 확정시(최초1회한) ※ 뇌혈관질환(뇌경색·뇌출혈): 거미막하출혈, 뇌내출혈, 기타 비외상성 두개내 출혈, 뇌경색증 ※ 보험계약일로부터 90일미만 시 보험가입금액 10% 지급 90일이상 1년미만 시 보험가입금액의 50% 지급	1천만원	20년	
104 통합 뇌질환진단비(뇌전증진단비)Ⅲ(355간편가입)(경신형) 보험기간 중에 "뇌전증"(약관참조)으로 진단 확정시(최초1회한) ※ 보험계약일로부터 90일미만 시 보험가입금액 10% 지급 90일이상 1년미만 시 보험가입금액의 50% 지급	1천만원	20년	
106 통합 뇌질환진단비(일과성뇌허혈발작진단비)Ⅲ(355간편가입)(경신형) 보험기간 중에 "일과성뇌허혈발작"(약관참조)으로 진단 확정시(최초1회한) ※ 보험계약일로부터 90일미만 시 보험가입금액 10% 지급 90일이상 1년미만 시 보험가입금액의 50% 지급	50만원	20년	
117 부정맥질환(Ⅰ49)진단비Ⅲ(355간편가입)(경신형) 보험기간 중에 "부정맥질환(Ⅰ49)"으로 진단확정된 경우(최초 1회한) ※ 최초보험계약일로부터 90일미만시 가입금액의 10% 지급, 90일이상 1년미만시 가입금액의 50% 지급	1천만원	20년	
125 심장질환(특정Ⅱ)진단비Ⅲ(355간편가입)(경신형) 보험기간 중에 심장질환(특정Ⅱ)(심장질환(특정Ⅱ) 분류표 참조)으로 진단확정된 경우(최초 1회한) - 보험계약일로부터 90일 미만시 보험가입금액의 10% 지급 보험계약일로부터 90일 이상 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급 ※ 심장질환(특정Ⅱ): 급성 심근경색증, 후속 심근경색증, 급성 심근경색증 후 특정 현존 합병증, 인공소생에 성공한 심장정지	1천만원	20년	
158 혈전용해치료비Ⅱ(최초1회한)(특정심장질환)(355간편가입)(경신형) 보험기간 중 특정심장질환으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 "혈전용해치료"를 받은 경우(최초1회한) ※ 보험계약일로부터 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급	1천만원	20년	
160 혈전용해치료비Ⅱ(최초1회한)(뇌졸중)(355간편가입)(경신형) 보험기간 중 뇌졸중으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 "혈전용해치료"를 받은 경우(최초1회한) ※ 보험계약일로부터 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급	1천만원	20년	
164 특정순환계질환 항응고제치료(경구용 항응고제-와파린 치료비(급여))(355간편가입)(경신형) 보험기간 중에 특정순환계질환(약관참조)으로 180일 이상의 기간동안 "경구용 항응고제 와파린 치료(급여)"를 받은 경우(최초1회한, 보험계약일부터 1년미만시 50% 지급) ※ "경구용 항응고제-와파린(급여)"이라 함은 "약제 급여 목록 및 급여 상환금액표"에서 정한 분류번호가 "333(혈액응고저지제)"에 해당하는 약제 중 warfarin sodium 성분명을 가지는 경우를 말합니다.	1백만원	5년	
166 특정순환계질환 항응고제치료(경구용 항응고제-NOAC 치료비(급여))(355간편가입)(경신형) 보험기간 중에 특정순환계질환(약관참조)으로 180일 이상의 기간동안 "경구용 항응고제 NOAC 치료(급여)"를 받은 경우(최초1회한, 보험계약일부터 1년미만시 150% 지급, 보험계약일부터 1년이상시 300% 지급) ※ "경구용 항응고제-NOAC(급여)"이라 함은 "약제 급여 목록 및 급여 상환금액표"에서 정한 분류번호가 "333(혈액응고저지제)"에 해당하는 약제 중 경구용 혈액응고인자 Xa 저해제나 경구용 트롬빈 직접 저해제를 말합니다.	1백만원	5년	

KB마크가 있는 경우에만 원본으로 인정됩니다.

KB마크

대표이사
사장대표이사
사장

구본욱



KB 금융그룹

KB 손해보험

보장명 및 보장내용	가입금액	납입기간	보험기간
283 뇌혈관질환수술비(355간편가입)(경신형)			
보험기간중 뇌혈관질환의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 (수술 1회당) ※ 보험계약일로부터 90일미만 시 보험가입금액 10% 지급 90일이상 1년미만 시 보험가입금액의 50% 지급	1천만원	20년	
285 심장질환수술비(355간편가입)(경신형)			
보험기간중 심장질환(심장질환 분류표 참조)의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 (수술 1회당) - 보험계약일로부터 90일 미만시 : 보험가입금액의 10% 지급 - 보험계약일로부터 90일이상 1년미만시 : 보험가입금액의 50% 지급	1천만원	20년	

※ 암, 질병의 범위 및 보장하는 내용 등은 반드시 약관을 참고하시기 바랍니다.

* 기타 유의사항

구분	내용
공통사항	상해담보 가입시, 이륜차운전중상해 부담보 특별약관에 가입한 경우 이륜자동차 또는 원동기장치 자전거(전동킥보드, 전동이륜행차, 전동기의 동력만으로 움직일 수 있는 자전거 등 개인형 이동장치를 포함하며, 전동휠체어, 의료용 스쿠터 등 보행보조용 의자차는 제외합니다)를 운전(탑승 포함)하는 중에 발생한 상해사고 또는 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우에 보험금을 지급하지 않거나 보장보험료 납입을 면제하지 않습니다. 또한, 보험기간 중에 피보험자가 직업/직무를 변경하거나 이륜자동차를 계속적으로 사용(직업, 직무 또는 동호회 활동과 출퇴근용도 등으로 주기적으로 운전(탑승 포함)하는 경우에 한합니다)하게 된 경우에는 지체없이 회사에 알려야 하며, 그렇지 않은 경우 보험금 지급이 거절되거나 감액될 수 있습니다. 위 자료는 약관 내용 중 일부를 요약한 자료로 표기된 가입금액과 실제 지급되는 보상금액이 다를 수 있으며, 기타 보험금을 지급하지 않는 사유 등은 반드시 약관 내용을 참조 바랍니다.
보험수익자와 회사가 보험금 지급사유에 대해 합의하지 못할 경우	보험수익자와 회사가 보험금 지급사유에 대해 합의하지 못할 때는 보험수익자와 회사가 함께 제3자를 정하고 그 제3자의 의견에 따를 수 있습니다. 제3자는 의료법 제3조(의료기관)에 규정한 종합병원 소속 전문의 중에 정하며, 보험금 지급사유 판정에 드는 의료비용은 회사가 전액 부담합니다.
일반심사형 가입을 희망하는 경우	계약자가 최초계약의 계약일로부터 3개월 이내에 일반심사형 상품으로 가입을 희망하는 경우, 동일한 피보험자를 대상으로 일반심사를 통하여 일반심사형 상품을 청약할 수 있는 기회를 제공해드립니다. 다만, 본계약의 보험금이 이미 지급되거나 청구서류를 접수한 경우에는 그러하지 않습니다. 일반심사형 상품에 가입하는 경우에는 본계약을 무효로 하여 이미 납입한 보험료를 돌려드립니다.
갱신계약에 관한 사항	1) 보험료 계산에 관한 사항 가) [갱신계약] 기본계약 및 특별약관은 갱신주기마다 자동갱신 됩니다.(3년, 5년, 10년, 15년, 20년, 30년) 나) 갱신시 보험기간 및 납입기간은 갱신전 계약의 보험기간 및 납입기간과 동일하게 적용합니다. 단, 갱신시점에서 갱신종료나이까지 잔여보험기간이 갱신전 계약의 보험기간보다 짧은 경우에는 그 잔여보험기간으로 갱신합니다. 다) [갱신계약] 기본계약 및 특별약관의 갱신시 보험료 통보 - 회사는 갱신전 계약의 보험기간이 종료되기 15일 이전까지 계약자에게 납입할 갱신계약의 보험료를 통보합니다. 라) 나)에도 불구하고 재진단암진단비(355간편가입) [갱신계약], 신재진단암진단비 II (기타피부암, 갑상선암 포함)(355간편가입) [갱신계약], 재진단암진단비 [갱신계약], 신재진단암진단비 II (기타피부암, 갑상선암 포함) [갱신계약]의 경우, 갱신시점에서 98세(갱신종료나이-2세)까지의 잔여보험기간이 갱신전 계약의 보험기간 보다 짧은 경우에는 98세(갱신종료나이-2세)까지의 잔여보험기간으로 갱신하며, 갱신시점 나이가 98세(갱신종료나이-2세) 이상인 경우에는 1년을 보험기간으로 하여 갱신합니다. 라-1) 나) 및 라)에도 불구하고 재진단암진단비(355간편가입) [갱신계약], 신재진단암진단비 II (기타피부암, 갑상선암 포함)(355간편가입) [갱신계약], 재진단암진단비 [갱신계약], 신재진단암진단비 II (기타피부암, 갑상선암 포함) [갱신계약]의 경우, 피보험자에게 98세 (갱신종료나이-2세)까지 '첫번째 암'이 진단확정되지 않은 경우에는 98세(갱신종료나이-2세) 갱신시점부터 더 이상 갱신하지 않으며, 갱신을 종료합니다. 마) 나)에도 불구하고 신재진단암 II 표적항암약물허가치료비(355간편가입) [갱신계약], 신재진단암 II 표적항암약물허가치료비 [갱신계약]의 경우, 갱신시점에서 99세(갱신종료나이-1세)까지의 잔여보험기간이 갱신전 계약의 보험기간 보다 짧은 경우에는 99세(갱신종료나이-1세)까지의 잔여보험기간으로 갱신하며, 갱신시점 나이가 99세(갱신종료나이-1세)인 경우에는 1년을 보험기간으로 하여 갱신합니다.

KB마크가 있는 경우에만 원본으로 인정됩니다.

KB마크

대표이사
사 장 사 용 구 본 목

위임장

위임인은 아래의 보험업법 제 188조 및 보험업감독규정,
보험업감독업무시행세칙에서 손해사정업무로써 정한 사항과 사고조사, 손해조사 등
의무기록확인 등 위임인의 정당한 권한을 위임합니다.

아 래

1. 보험업법 제188조의 법정 손해사정업무
 - ① 손해발생 사실의 확인
 - ② 보험약관 및 관계법규적용의 적정여부 판단
 - ③ 손해액 및 보험금 사정
 - ④ 제1호 내지 제3호의 업무와 관련한 서류의 작성·제출의 대행
 - ⑤ 제1호 내지 제3호의 업무의 수행과 관련한 보험회사에 대한 의견의 진술
2. 보험업감독규정 제9-21조(손해사정서 접수 및 처리절차 등)
3. 보험업감독업무시행세칙 제6-20조(전문인의 활용)
전문지식이 요구되는 법률자문, 약관해석, 안전진단, 의료분석·감정, 수리견적 등
해당 전문인의 자문, 진단, 소견, 견적 등의 업무
4. 경찰서, 소방서 등 관공서 및 공공기관, 의료기관 등 정보 열람, 발급업무
5. 기타 손해사정 조사업무와 관련한 위임인의 권한 일체

יחזקאל

위임인 성명: (대리인)

주민번호 :

전화번호 :

주소:

바른걸 손해사정 귀중